40 Minggu dengan Tenang

Edisi 1: Trimester 1 (sampai Usia Kehamilan 13 Minggu)

dr. Bayu Maulana, SpOG

Edisi 1 · November 2026

40 Minggu dengan Tenang

Edisi 1: Trimester 1 (sampai Usia Kehamilan 13 Minggu)
dr. Bayu Maulana, SpOG
Edisi 1 · November 2026

Lisensi

© 2026 dr. Bayu Maulana, SpOG. E-book ini dilisensikan hanya untuk penggunaan pribadi pembeli. Dilarang menyalin, membagikan, mengunggah ulang, atau menjual kembali sebagian maupun seluruh isinya tanpa izin tertulis dari penulis.

Tentang Edisi 1. Edisi ini memuat bab Trimester 1 (sampai usia kehamilan 13 minggu) dan disertai bonus Checklist Kehamilan per Trimester (PDF terpisah). Bab Trimester 2, Trimester 3, serta persalinan dan masa nifas sedang disusun dan akan ditambahkan secara bertahap. Pembeli edisi ini mendapat pembaruan tersebut tanpa biaya tambahan melalui halaman unduhan yang sama.

Dalam keadaan gawat darurat, hubungi **119** atau segera ke **IGD terdekat**.

Surat untuk Ibu

Ibu yang sedang menanti buah hati,

Banyak ibu datang periksa dengan membawa segudang pertanyaan, dan tidak semuanya sempat terjawab dalam satu kali kunjungan. Buku ini saya tulis agar Ibu punya teman membaca di rumah. Bahasanya saya buat sesederhana mungkin, dan isinya saya susun dari pedoman resmi, seperti Buku KIA Kementerian Kesehatan, WHO, dan perhimpunan dokter kandungan.

Kehamilan yang sehat adalah kerja bersama. Banyak hal penting justru terjadi di rumah: minum tablet tambah darah setiap hari, makan bergizi, istirahat cukup, dan mengenali tanda bahaya sejak dini. Karena itu, ajaklah suami dan keluarga ikut membaca buku ini.

Edisi pertama ini berisi bab Trimester 1, yaitu masa sampai usia kehamilan 13 minggu. Nomor bab mengikuti susunan buku lengkap, sehingga bab di edisi ini bernomor Bab 3. Bab Trimester 2, Trimester 3, serta persalinan dan masa nifas menyusul secara bertahap sebagai pembaruan tanpa biaya tambahan bagi Ibu yang sudah memiliki edisi ini.

Pakailah buku ini bersama Buku KIA, dan catat pertanyaan Ibu untuk dibawa saat kontrol. Buku ini tidak menggantikan pemeriksaan. Bila muncul tanda bahaya, jangan menunggu: hubungi **119** atau segera ke **IGD terdekat**.

Semoga 40 minggu ini Ibu jalani dengan tenang.

Salam hangat,

dr. Bayu Maulana, SpOG
Lampung Tengah

Daftar Isi

Surat untuk Ibu 4

Penting untuk Dibaca Lebih Dulu (Disclaimer) 6

Bab 3. Trimester 1: Fondasi yang Menentukan 7

3.1 Selamat Datang di Trimester Pertama 7

3.2 Perubahan Tubuh Ibu dan Perkembangan Janin 8

3.3 Keluhan Umum dan Cara Mengatasinya 10

3.4 Nutrisi dan Suplemen 13

3.5 Pemeriksaan Kehamilan dan Jadwal ANC 19

3.6 USG Trimester 1 21

3.7 Pemeriksaan Laboratorium dan Skrining 23

3.8 Imunisasi 25

3.9 Aktivitas Fisik dan Olahraga 26

3.10 Hubungan Suami-Istri 28

3.11 Obat, Jamu, dan Hal yang Sebaiknya Dihindari 28

3.12 Tanda Bahaya Trimester 1 30

3.13 Kapan ke Dokter, Kapan ke IGD 32

3.14 Pertanyaan yang Sering Diajukan di Ruang Praktik 32

3.15 Ringkasan Trimester 1 34

Sumber (Bab 3) 35

Penting untuk Dibaca Lebih Dulu (Disclaimer)

E-book ini adalah **bahan edukasi umum** untuk ibu hamil dan keluarganya. Isinya **bukan pengganti pemeriksaan, diagnosis, atau pengobatan** oleh dokter, bidan, atau tenaga kesehatan yang memeriksa Ibu langsung. Setiap kehamilan berbeda. Jika ada keluhan, atau Ibu ragu, segera periksa ke fasilitas kesehatan.

Dalam keadaan gawat darurat, hubungi **119** (layanan ambulans/gawat darurat medis Kemenkes) atau **segera ke IGD terdekat**. Bila Ibu berada di area Lampung Tengah: RS Harapan Bunda, 0800 1503363.

Isi e-book disusun dari pedoman resmi, yaitu Buku KIA 2024 Kementerian Kesehatan RI, peraturan Kemenkes, rekomendasi WHO, ACOG, serta POGI–HKFM. Sumber dicantumkan di akhir setiap bab. E-book ini tidak menyebut atau menganjurkan merek obat, suplemen, susu, maupun alat kesehatan, dan tidak menganjurkan fasilitas kesehatan tertentu. Satu nomor rumah sakit di Lampung Tengah dicantumkan hanya sebagai informasi kontak bagi pembaca di wilayah tersebut. Obat dan suplemen ditulis dengan nama generiknya saja. Dosis dan pilihan obat untuk Ibu tetap ditentukan oleh dokter atau bidan yang memeriksa.

Bab 3. Trimester 1: Fondasi yang Menentukan

3.1 Selamat Datang di Trimester Pertama

Selamat, Ibu! Trimester pertama adalah tiga bulan awal kehamilan. Di masa ini organ-organ penting bayi mulai terbentuk, padahal perut Ibu mungkin belum terlihat berubah. Banyak ibu justru merasa paling lelah dan paling mual di trimester ini. Itu wajar. Bab ini membantu Ibu memahami apa yang sedang terjadi, apa yang perlu dilakukan, dan kapan harus segera mencari pertolongan.

Di buku ini, **trimester pertama** dihitung sampai usia kehamilan **13 minggu**, **trimester kedua 14–27 minggu**, dan **trimester ketiga mulai 28 minggu**. Buku KIA 2024 mencatat trimester pertama sebagai **12 minggu pertama** kehamilan. Perbedaan beberapa hari ini tidak perlu membuat Ibu khawatir. Yang penting, Ibu **periksa sedini mungkin**. Buku KIA menganjurkan segera ke fasilitas kesehatan bila haid **terlambat 1 minggu**.

> Banyak ibu yang datang di awal kehamilan merasa senang sekaligus cemas, apalagi saat mual mulai datang. Itu wajar. Pesan saya: periksa sedini mungkin, minum tablet tambah darah setiap hari, dan jangan ragu bertanya, karena tidak ada pertanyaan yang terlalu sepele.

Usia kehamilan dihitung dari mana? Usia kehamilan biasanya dihitung dari **Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT)**, bukan dari tanggal pembuahan. Jadi pada "minggu ke-4" sebenarnya janin baru berumur sekitar 2 minggu. Jika siklus haid Ibu tidak teratur atau Ibu lupa tanggal HPHT, USG di trimester pertama membantu dokter menentukan usia kehamilan dan HPL dengan lebih tepat (lihat 3.6).

3.2 Perubahan Tubuh Ibu dan Perkembangan Janin

Yang dialami Ibu

Menurut Buku KIA 2024, pada trimester pertama Ibu dapat mengalami:

- **Mual, muntah, dan mudah lelah.**
- **Kenaikan berat badan sekitar 1–3 kg**, disesuaikan dengan grafik kenaikan berat badan di Buku KIA. Ada juga ibu yang berat badannya tetap atau sedikit turun karena mual. Sampaikan ke dokter atau bidan bila berat badan turun.
- Masa ini juga **rentan terjadi keguguran**, sehingga mengenali tanda bahaya sangat penting.

Perubahan lain yang sering dikeluhkan antara lain payudara terasa kencang atau nyeri, lebih sering buang air kecil, perut kembung, sembelit, lebih sensitif terhadap bau, dan perasaan yang naik-turun. Sebagian besar keluhan ini disebabkan perubahan hormon dan biasanya membaik di trimester kedua.

Keluhan "kecil" yang sering ditanyakan

Banyak ibu bertanya tentang keluhan di bawah ini. Sebagian besar tidak berbahaya, dan Ibu sama sekali tidak merepotkan bila menanyakannya. Yang penting, kenali batasnya.

- **Keputihan.** Bila tidak berbau, tidak gatal, dan tidak berwarna, cukup jaga kebersihan dan pakai celana dalam katun (lihat tabel di 3.3). **Periksa** bila keputihan **berbau, gatal, atau berwarna** (tanda bahaya Buku KIA 2024). **Segera periksa** bila yang keluar adalah **cairan** atau **darah** dari jalan lahir.
- **Pusing atau rasa melayang.** Keluhan ini cukup sering di awal kehamilan (HSE). Untuk mencegahnya, bangun pelan-pelan dan duduk dulu sebentar di tepi tempat tidur sebelum berdiri. Jangan melewatkan waktu makan, makanlah sedikit tapi sering, cukupi minum, dan hindari berdiri terlalu lama atau mandi air yang sangat

panas. Bila terasa hendak pingsan, duduk dan tundukkan kepala, atau berbaring miring, tarik napas pelan-pelan, longgarkan pakaian, dan minta orang terdekat menemani (HSE). **Segera periksa** bila pusing disertai **perdarahan, nyeri perut, sesak atau nyeri dada, jantung berdebar sangat cepat, sakit kepala hebat, pandangan kabur**, pusing berat yang tidak hilang, atau bila Ibu **sampai pingsan** (HSE; ACOG FAQ155; lihat 3.13). Pusing yang muncul bersama muntah terus-menerus dibahas di 3.3.

- **Nyeri perut bawah ringan.** Rasa tidak nyaman yang ringan bisa disebabkan sembelit, perut kembung, atau peregangan jaringan penyangga rahim. Biasanya keluhan membaik setelah Ibu beristirahat, berganti posisi, buang air besar, atau buang angin (NHS). Namun **segera periksa** bila nyeri **hebat**, **tidak hilang setelah istirahat 30–60 menit**, atau disertai **flek atau perdarahan, nyeri bahu, lemas atau pingsan, demam, atau sakit saat kencing** (NHS; Buku KIA 2024; ACOG FAQ155). Lihat 3.12 dan 3.13.
- **Kram kaki.** Kram betis sering muncul pada malam hari, terutama di kehamilan lanjut. Saat kram datang, regangkan dan pijat otot betis, atau berdiri dan tumpukan berat badan pada kaki yang kram. Peregangan betis secara rutin, termasuk sebelum tidur, dapat membantu mengurangi kram (NHS). **Periksa** bila kram berlangsung **lebih dari 10 menit**, mengganggu tidur, atau disertai kebas atau bengkak. **Nyeri atau bengkak di betis** perlu segera diperiksa (NHS; ACOG FAQ119).

Yang dialami bayi

Buku KIA 2024 menggambarkan perkembangan bayi di trimester pertama seperti ini:

- **Bulan ke-1:** kira-kira sebesar **biji beras**.
- **Bulan ke-3:** kira-kira sebesar **jeruk nipis**.

- Bagian tubuh bayi, **termasuk otak, mulai terbentuk**. Inilah sebabnya trimester pertama disebut masa penting pembentukan bagian tubuh janin.

Karena organ sedang terbentuk, Ibu perlu menghindari zat yang berbahaya bagi janin, misalnya rokok, alkohol, serta obat atau jamu tanpa resep. Ibu juga perlu cukup asam folat (lihat 3.4 dan 3.11).

3.3 Keluhan Umum dan Cara Mengatasinya

Mual dan muntah ("morning sickness")

Mual dan muntah sangat umum di awal kehamilan. Walaupun sering disebut *morning sickness*, mual bisa muncul **kapan saja**, pagi, siang, maupun malam. Menurut ACOG, mual biasanya mulai **sebelum usia kehamilan 9 minggu** dan pada sebagian besar ibu **mereda sekitar 14 minggu**. Pada sebagian kecil ibu, mual berlangsung lebih lama. Mual dan muntah biasa umumnya **tidak membahayakan janin** dan **bukan tanda janin sakit**, tetapi bisa sangat mengganggu aktivitas Ibu.

Langkah yang bisa Ibu coba di rumah (dirangkum dari Buku KIA 2024, ACOG, dan WHO):

1. **Makan sedikit tapi sering.** Buku KIA menganjurkan 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Usahakan perut tidak pernah benar-benar kosong.
2. **Siapkan camilan kering di samping tempat tidur**, misalnya biskuit tawar atau roti kering. Makan sedikit **sebelum bangun** dari tempat tidur di pagi hari.
3. **Pilih makanan yang hambar dan mudah dicerna**, misalnya nasi, roti, pisang, atau bubur. Tujuannya sederhana: temukan makanan yang bisa masuk dan tidak dimuntahkan.
4. **Tambahkan protein** di setiap makan, misalnya telur, tahu, tempe, ikan, kacang-kacangan, atau susu dan produk olahannya bila cocok untuk Ibu.

5. **Jahe** dapat membantu meredakan mual, misalnya wedang jahe dari jahe segar. WHO juga mencantumkan jahe, chamomile, vitamin B6, dan/atau akupunktur sebagai pilihan untuk meredakan mual di awal kehamilan, sesuai keinginan ibu dan ketersediaan.
6. **Minum sedikit-sedikit tetapi sering** sepanjang hari, jangan menunggu haus. Buku KIA menganjurkan **8–12 gelas air putih per hari**. Jika mulut terasa tidak enak, mengunyah permen bisa membantu.
7. **Hindari bau pemicu.** Gunakan kipas atau buka jendela saat memasak, dan minta anggota keluarga membantu membuang sampah.
8. **Minum tablet tambah darah (TTD/MMS) pada malam hari sebelum tidur.** Buku KIA menyarankan cara ini untuk mengurangi rasa mual.
9. **Lindungi gigi setelah muntah.** Asam lambung dapat mengikis email gigi. ACOG menyarankan berkumur dengan larutan 1 sendok teh soda kue dalam 1 gelas air.
10. **Minta bantuan keluarga.** Istirahat yang cukup sangat membantu. Buku KIA menganjurkan tidur malam paling sedikit 6–7 jam dan tidur siang 1–2 jam.

Bagaimana dengan obat antimual? Jika cara di atas belum membantu, **bicarakan dengan dokter**. Ada obat yang dapat dipertimbangkan dokter, misalnya **vitamin B6** dan **obat antimual lain yang diresepkan dokter**. Dokter akan memilih sesuai kondisi Ibu dan menimbang manfaat serta risikonya. **Jangan membeli dan minum obat antimual sendiri.**

Kapan mual-muntah menjadi berbahaya (hiperemesis gravidarum)

Bentuk paling berat dari mual-muntah kehamilan disebut **hiperemesis gravidarum**. Menurut ACOG, kondisi ini terjadi pada sampai sekitar 3 dari 100 kehamilan dan sering memerlukan perawatan, kadang di rumah sakit, untuk mengganti cairan tubuh.

Segera periksa bila Ibu mengalami tanda-tanda kekurangan cairan (dehidrasi) berikut:

- Kencing **sangat sedikit dan berwarna gelap**, atau **tidak bisa kencing**.
- **Tidak bisa menahan minuman sama sekali**; semua yang diminum keluar lagi.
- **Pusing atau hampir pingsan** saat berdiri.
- **Jantung berdebar** cepat.
- **Berat badan terus turun.**

Periksakan juga bila mual-muntah **baru muncul pertama kali setelah usia 9 minggu**, atau disertai **nyeri perut, demam, sakit kepala**, atau **benjolan di leher depan**. Keluhan seperti ini bisa disebabkan kondisi lain, misalnya gangguan lambung, keracunan makanan, tiroid, atau kantung empedu, sehingga perlu diperiksa dokter. Buku KIA 2024 memasukkan **"mual dan muntah hebat"** ke dalam **tanda bahaya trimester 1**.

Kapan langsung ke IGD? Bila **sejak pagi tidak ada minuman yang bisa masuk** (semua yang diminum keluar lagi), jangan menunggu jadwal kontrol atau esok hari. **Segera ke IGD.**

Keluhan lain yang sering terjadi

Keluhan	Yang bisa dilakukan	Periksa ke dokter/bidan bila...
Mudah lelah, mengantuk	Istirahat dan tidur cukup; minta bantuan pekerjaan rumah	Lelah disertai pucat, berdebar, sesak (curiga anemia)
Sering buang air kecil	Wajar karena rahim membesar; tetap minum cukup, jangan menahan kencing	**Sakit/perih saat kencing**, demam, nyeri pinggang (tanda bahaya Buku KIA)
Payudara kencang/nyeri	Bra yang nyaman dan menopang	Ada benjolan yang menetap
Sembelit, kembung	Sayur, buah, air putih cukup, aktivitas ringan	Nyeri perut hebat, BAB berdarah
Keputihan	Jaga kebersihan, celana dalam katun	Keputihan **berbau, gatal, atau berwarna** (tanda bahaya Buku KIA)
Perasaan naik-turun, cemas	Bicara dengan suami/ keluarga, istirahat	**Sulit tidur dan cemas berlebihan**, sedih terus-menerus (Buku KIA)
Flek/bercak darah	Jangan menebak sendiri	**Setiap perdarahan di trimester 1, sekecil apa pun: segera ke IGD/ fasilitas kesehatan hari itu juga** (lihat 3.12 dan 3.13)

3.4 Nutrisi dan Suplemen

Makan untuk dua? Tidak harus dua kali lipat

Hamil tidak berarti makan dua kali lebih banyak, melainkan makan **dua kali lebih bergizi**. Di trimester pertama yang penuh mual, fokuslah pada pola makan sedikit tapi sering dan beragam.

Buku KIA 2024 memuat **tabel porsi makan dan minum ibu hamil untuk 12 minggu pertama**, antara lain:

Kelompok makanan	Porsi sehari (T1)	Contoh 1 porsi (Buku KIA)
Nasi atau makanan pokok	5 porsi	100 g atau ¾ gelas nasi; 125 g atau 3 buah jagung sedang; 210 g atau 2 kentang sedang
Protein hewani	4 porsi	50 g atau 1 potong sedang ikan; 55 g atau 1 butir telur ayam
Protein nabati	4 porsi	50 g atau 1 potong sedang tempe; 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	100 g atau 1 potong sedang pisang; 100–190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/lemak	5 porsi	5 g atau 1 sendok teh (termasuk untuk menggoreng/ menumis/santan)
Gula	2 porsi	10 g atau 1 sendok makan

Buku KIA juga menganjurkan **garam paling banyak 1 sendok teh per hari**, **air putih 8–12 gelas per hari**, dan porsi makan disesuaikan dengan **bahan pangan lokal**.

Contoh menu sehari (trimester 1) dengan bahan yang mudah didapat di pasar

Contoh ini disusun mengikuti tabel porsi Buku KIA 2024 di atas (5 porsi makanan pokok, 4 protein hewani, 4 protein nabati, 4 sayur, 4 buah, 5 minyak, 2 gula). Bahan boleh ditukar dengan yang ada di rumah atau yang sedang musim, asal kelompok dan porsinya sama.

Waktu	Menu	Hitungan porsi
Pagi	Nasi ¾ gelas, telur rebus atau dadar 1 butir, tempe bacem atau goreng 1 potong sedang, tumis kangkung 1 mangkuk	1 pokok, 1 hewani, 1 nabati, 1 sayur, 1 minyak
Selingan pagi	Jagung rebus (1 porsi sesuai tabel), pisang 1 potong sedang	1 pokok, 1 buah
Siang	Nasi 1½ gelas, ikan (misalnya nila, lele, atau kembung) 1 potong sedang dibakar atau dipepes, tahu 2 potong sedang, sayur asem 1 mangkuk, urap sayur 1 mangkuk, sambal secukupnya	2 pokok, 1 hewani, 1 nabati, 2 sayur, 2 minyak
Selingan sore	Pepaya 1 potong besar, telur rebus 1 butir	1 buah, 1 hewani
Malam	Nasi ¾ gelas, ikan atau ayam 1 potong sedang, tempe 1 potong sedang dan tahu 2 potong sedang, sayur bening bayam atau daun singkong 1 mangkuk	1 pokok, 1 hewani, 2 nabati, 1 sayur, 2 minyak
Sebelum tidur	TTD/MMS bersama 1 porsi buah sumber vitamin C, misalnya jeruk atau jambu biji (Buku KIA: TTD diminum malam hari bersama vitamin C, tidak bersama teh, kopi, atau susu)	1 buah

Gula untuk bumbu atau minuman paling banyak **2 sendok makan** sehari, dan garam beryodium paling banyak **1 sendok teh** sehari. Minum air putih **8–12 gelas** sehari (Buku KIA 2024). Pastikan ikan, ayam, dan telur **dimasak sampai matang**. Bila mual, bagi porsi di atas menjadi lebih banyak waktu makan yang lebih kecil (lihat 3.3).

Suplemen yang dianjurkan

1. Tablet Tambah Darah (TTD) atau suplemen multivitamin-mineral ibu hamil (MMS), setiap hari selama kehamilan

Buku KIA 2024 dan Permenkes 6/2024 menetapkan pemberian TTD **setiap hari selama kehamilan**. Menurut Buku KIA, TTD/MMS **sedikitnya berisi 30–60 mg zat besi dan 400 mikrogram asam folat**. Angka ini sejalan dengan rekomendasi WHO 2016, yaitu zat besi elemental 30–60 mg dan asam folat 400 µg per hari untuk mencegah anemia, bayi berat lahir rendah, dan kelahiran prematur.

Cara minum agar lebih efektif (Buku KIA 2024):

- Minum **setiap hari**, sebaiknya **malam hari sebelum tidur** untuk mengurangi mual.
- Minum bersama makanan atau minuman yang mengandung **vitamin C**, misalnya buah-buahan.
- **Jangan diminum bersamaan dengan teh, kopi, susu, atau obat maag**, karena dapat menghambat penyerapan zat besi.
- Gunakan tabel centang TTD/MMS di Buku KIA agar tidak terlewat.

Efek samping yang mungkin muncul adalah tinja berwarna gelap, mual, atau sembelit. Jika mengganggu, **jangan berhenti sendiri**. Sampaikan ke bidan atau dokter.

2. Asam folat

Asam folat membantu mencegah **cacat tabung saraf** (kelainan otak dan tulang belakang bayi). Menurut ACOG, idealnya suplemen yang mengandung **minimal 400 mikrogram asam folat** sudah diminum **sejak sedikitnya 1 bulan sebelum hamil** dan dilanjutkan selama 12 minggu pertama kehamilan. WHO menganjurkan asam folat dimulai sedini mungkin, idealnya sebelum hamil. Jika Ibu baru tahu hamil dan belum minum, **mulailah sekarang**. Biasanya asam folat sudah terkandung dalam TTD/MMS.

Ibu yang **pernah memiliki anak dengan cacat tabung saraf** memerlukan asam folat dengan dosis lebih tinggi (ACOG). Bila Ibu memiliki riwayat ini, sampaikan ke dokter, sebaiknya sejak merencanakan kehamilan. **Dosis ini ditentukan dan diresepkan dokter**; jangan menambah dosis sendiri.

3. Kalsium

Kalsium dibutuhkan untuk tulang dan gigi bayi. Menurut ACOG, kebutuhan kalsium harian ibu hamil adalah **1.000 mg (usia 19–50 tahun)** dan **1.300 mg (usia 14–18 tahun)**. Sumbernya antara lain susu dan produk olahannya, ikan kecil yang dimakan bersama tulangnya (misalnya teri), sayuran hijau tua, tahu, dan tempe.

WHO juga merekomendasikan **suplemen kalsium untuk ibu hamil di populasi yang asupan kalsium hariannya rendah**, dengan tujuan **menurunkan risiko preeklamsia**. WHO menyebut suplemen ini dapat dimulai **sejak kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama**. WHO juga menyarankan suplemen kalsium dan zat besi **diminum berselang beberapa jam**, tidak bersamaan.

Dokter dapat memberikan suplemen kalsium sejak kunjungan pertama, terutama bila **asupan kalsium harian Ibu dari makanan rendah** (WHO). Minumlah **sesuai anjuran dokter atau bidan**, dan jangan menambah atau menghentikannya sendiri. Makanan sumber kalsium tetap penting.

4. Yodium

Yodium penting untuk **perkembangan otak bayi**. Menurut ACOG, kebutuhan yodium ibu hamil adalah **220 mikrogram per hari**. Sumber utamanya **garam beryodium**, ditambah makanan laut, telur, dan produk susu. Gunakan garam beryodium untuk memasak, tetapi tetap dalam batas Buku KIA, yaitu **paling banyak 1 sendok teh garam per hari**.

Cara memastikan garam di rumah beryodium (Kemenkes):

- **Periksa label kemasan.** Pilih garam yang kemasannya bertuliskan **"Garam Beryodium"**. Standar Nasional Indonesia (SNI) menetapkan kadar yodium garam konsumsi **30–80 ppm** (Kemenkes, Ditjen Kesehatan Lanjutan).
- **Bila ragu, garam bisa diuji dengan cairan uji yodium.** Teteskan 2–3 tetes pada garam. Bila warnanya berubah menjadi **biru keunguan**, garam mengandung yodium. Tes cepat ini hanya menunjukkan ada atau tidaknya yodium, bukan kadarnya (Kemenkes, Buku Surveilans GAKI).
- Tetap gunakan secukupnya, **paling banyak 1 sendok teh garam per hari** (Buku KIA 2024).

Hal penting tentang suplemen

- **Jangan menggandakan dosis vitamin** sendiri. ACOG mengingatkan bahwa beberapa kandungan, seperti vitamin A, dapat menyebabkan cacat lahir bila diminum berlipat dosis.
- Beri tahu dokter atau bidan **semua vitamin, suplemen, dan jamu** yang sedang Ibu konsumsi. Bawa kemasannya saat periksa.
- Vitamin hanya pelengkap dan **tidak menggantikan makanan bergizi**.

Makanan dan minuman yang perlu dibatasi atau dihindari

- **Alkohol**: hindari sama sekali (Buku KIA).
- **Kopi, teh, dan minuman bersoda**: batasi (Buku KIA). Jangan diminum bersamaan dengan TTD.
- **Ikan mentah dan kerang mentah** (misalnya sushi), **daging dan telur yang tidak matang**: lebih berisiko menyebabkan infeksi. Masak hingga matang.
- **Ikan tinggi merkuri**: ACOG menyarankan menghindari antara lain **hiu, ikan todak (swordfish), marlin, king mackerel, tilefish, orange**

roughy, dan tuna mata besar (bigeye). Ikan lain yang rendah merkuri tetap dianjurkan sekitar 2–3 porsi per minggu. Nama ikan di daftar ini tidak selalu sama dengan nama ikan di pasar kita. **Untuk jenis ikan lokal, tanyakan kepada dokter atau ahli gizi.**

- **Susu yang tidak dipasteurisasi**: pilih produk susu yang sudah dipasteurisasi.

3.5 Pemeriksaan Kehamilan dan Jadwal ANC

Berapa kali harus periksa?

Menurut **Buku KIA 2024** dan **Permenkes Nomor 6 Tahun 2024**, ibu hamil periksa **paling sedikit 6 kali** selama kehamilan:

Trimester	Jumlah minimal	Keterangan
Trimester 1	**1 kali**	Termasuk pemeriksaan **dokter, USG, dan laboratorium lengkap**
Trimester 2	**2 kali**	Oleh dokter atau bidan
Trimester 3	**3 kali**	Salah satunya pemeriksaan dokter dan USG

Paling sedikit 2 kali pemeriksaan dilakukan **oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi**, yaitu **di trimester 1 dan trimester 3**, **termasuk USG**. Ini adalah **jumlah minimal**. Bila ada kondisi khusus, dokter atau bidan dapat meminta Ibu kontrol lebih sering. WHO (2016) bahkan menganjurkan model dengan **minimal 8 kontak** selama kehamilan. Ikuti jadwal kontrol yang diberikan tenaga kesehatan yang memeriksa Ibu.

Buku KIA 2024 juga mencatat bahwa **layanan pemeriksaan kehamilan tersedia gratis** bagi ibu hamil, meliputi pemeriksaan oleh dokter/bidan, TTD/multivitamin, pemeriksaan status gizi, tekanan darah, laboratorium,

skrining kesehatan jiwa, pemeriksaan kondisi bayi, imunisasi tetanus, **USG 2 kali**, dan kelas ibu hamil.

Memakai JKN/BPJS Kesehatan untuk periksa hamil (garis besar). Pastikan kepesertaan JKN Ibu **aktif**. Pemeriksaan dimulai di **fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat Ibu terdaftar**, misalnya Puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktik (Kemenkes). Bila Ibu memerlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan, FKTP akan **merujuk** Ibu ke rumah sakit. Dalam **keadaan gawat darurat**, Ibu **tidak perlu menunggu rujukan**: langsung ke IGD terdekat (Perpres 82/2018 Pasal 55 dan 63). Rincian layanan yang ditanggung, termasuk jumlah USG, dapat berubah. Tanyakan ke FKTP Ibu atau BPJS Kesehatan.

Apa saja yang diperiksa? ("10 T")

Setiap kali periksa, Ibu berhak mendapatkan pelayanan sesuai standar. Permenkes 6/2024 menyebutnya **10 T**:

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur tekanan darah. Tekanan darah **≥140/90 mmHg** termasuk hipertensi (Buku KIA).
3. Ukur Lingkar Lengan Atas (LiLA). LiLA **<23,5 cm** menandakan risiko kurang energi kronis (Buku KIA).
4. Ukur tinggi puncak rahim (tinggi fundus uteri)
5. Tentukan letak janin dan denyut jantung janin
6. Skrining status imunisasi tetanus dan beri imunisasi Td bila perlu
7. Beri tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan
8. Tes laboratorium
9. Tata laksana atau penanganan kasus
10. Temu wicara atau konseling

Ditambah **pelayanan USG** dan **skrining kesehatan jiwa**.

Kunjungan pertama dengan dokter biasanya meliputi wawancara riwayat kesehatan (penyakit Ibu dan keluarga, riwayat kehamilan dan

persalinan sebelumnya, alergi, obat yang diminum, kebiasaan seperti merokok atau alkohol), pemeriksaan fisik, USG, dan pengantar pemeriksaan laboratorium.

Tips: Bawa **Buku KIA** setiap kali periksa. Tulis pertanyaan Ibu sebelum berangkat, dan ajak suami bila memungkinkan.

3.6 USG Trimester 1

USG (ultrasonografi) memakai gelombang suara, bukan sinar-X, untuk melihat kehamilan. Di trimester pertama, USG bisa dilakukan lewat perut atau lewat vagina, tergantung usia kehamilan dan kebutuhan pemeriksaan.

Menurut lembar pemeriksaan dokter trimester 1 di Buku KIA 2024, USG trimester 1 antara lain menilai:

- **Letak kehamilan**: di dalam rahim (normal) atau di luar rahim (hamil ektopik, berbahaya).
- **Jumlah kantong kehamilan dan jumlah janin**: tunggal atau kembar.
- **Ukuran kantong kehamilan** dan **panjang janin dari puncak kepala ke bokong (CRL)**.
- **Denyut jantung janin.**
- **Usia kehamilan dan HPL.** Bila ukuran CRL sudah bisa diukur, usia kehamilan dan HPL ditentukan berdasarkan CRL dari USG trimester 1.
- Kecurigaan temuan yang tidak normal, untuk ditindaklanjuti.

WHO (pembaruan 2022) menganjurkan **satu kali USG sebelum usia kehamilan 24 minggu** untuk memperkirakan usia kehamilan, mendeteksi kelainan janin dan kehamilan kembar, serta meningkatkan pengalaman kehamilan ibu.

Bagaimana jika denyut jantung belum terlihat? Pada kehamilan yang masih sangat awal, denyut jantung bisa jadi memang belum tampak.

Dokter mungkin meminta Ibu **USG ulang** setelah beberapa waktu. Ini sering terjadi dan belum tentu berarti ada masalah.

Kapan USG pertama? Periksakan diri ke dokter atau bidan **segera setelah terlambat haid** (Buku KIA 2024 menganjurkan segera periksa bila haid terlambat 1 minggu). Dokter dapat melakukan USG pada kunjungan pertama. Bila USG dilakukan **sangat awal**, kantong kehamilan atau janin mungkin **belum terlihat**. Ini belum tentu berarti ada masalah; **dokter akan menentukan waktu USG berikutnya** sesuai usia kehamilan Ibu.

> **Jangan menunggu jadwal USG** bila Ibu mengalami **perdarahan, nyeri perut atau panggul, nyeri di bahu, lemas, atau pingsan**. **Segera ke IGD.** Dokter perlu segera memastikan kehamilan berada di dalam rahim, bukan kehamilan di luar kandungan (ektopik) (ACOG FAQ155).

Skrining kelainan kromosom (opsional). Di beberapa fasilitas tersedia skrining tambahan di usia kehamilan **10–13 minggu**, misalnya pengukuran ketebalan tengkuk janin (*nuchal translucency*) yang dikombinasikan dengan tes darah, atau tes DNA janin dari darah ibu (*cell-free DNA*) yang bisa dilakukan mulai 10 minggu (ACOG). Hasil skrining hanya menunjukkan **tinggi atau rendahnya risiko** dan **bukan diagnosis pasti**. Pemeriksaan ini **pilihan**, sehingga diskusikan dulu dengan dokter.

3.7 Pemeriksaan Laboratorium dan Skrining

Menurut Buku KIA 2024, pemeriksaan laboratorium ibu hamil meliputi:

Pemeriksaan	Untuk apa
Hemoglobin (Hb)	Mendeteksi **anemia** (kurang darah). Anemia membuat Ibu mudah lelah dan berisiko bagi ibu dan bayi.
Golongan darah dan rhesus	Persiapan bila suatu saat Ibu membutuhkan transfusi; mengetahui rhesus negatif
Gula darah sewaktu	Skrining kadar gula darah
Protein urin	Bersama tekanan darah, membantu mendeteksi **preeklamsia**
Tripel eliminasi: HIV, sifilis, hepatitis B	Jika ditemukan sejak dini, penularan dari ibu ke bayi dapat dicegah dengan penanganan yang tepat
Pemeriksaan lain sesuai indikasi	Ditentukan dokter sesuai kondisi Ibu

Tripel eliminasi bukan tuduhan. Tes HIV, sifilis, dan hepatitis B dianjurkan untuk **semua** ibu hamil, bukan hanya mereka yang dianggap berisiko. Banyak infeksi tidak menimbulkan gejala, dan hasilnya dijaga kerahasiaannya. Jika hasilnya reaktif, ada penanganan untuk melindungi Ibu dan bayi.

Saya paham, ditawari tes HIV, sifilis, dan hepatitis B bisa membuat Ibu kaget, cemas, atau malu. Perlu Ibu tahu: tes ini dianjurkan untuk **semua ibu hamil, bukan karena Ibu dicurigai**. Banyak infeksi tidak bergejala, sehingga tes adalah satu-satunya cara untuk mengetahuinya. Dengan tahu sejak awal, kita bisa mencegah penularan ke bayi.

Bila hasilnya reaktif, Ibu tidak sendirian. Dokter dan bidan akan menjelaskan langkah berikutnya untuk melindungi Ibu dan bayi. Program pemerintah juga mengatur agar **pasangan** dari ibu hamil dengan hasil reaktif ikut ditawari tes dan konseling, serta agar suami dan keluarga dilibatkan dalam pendampingan (Permenkes 52/2017). Karena

itu, bila disarankan, **ajaklah suami ikut tes**. Ini bukan soal menyalahkan siapa pun, melainkan cara menjaga seluruh keluarga.

Skrining risiko preeklamsia dan aspirin dosis rendah

Preeklamsia adalah kondisi tekanan darah tinggi dalam kehamilan yang dapat mengganggu organ ibu dan pertumbuhan bayi. Gejalanya biasanya muncul **setelah pertengahan kehamilan**, tetapi **risikonya sudah dapat dinilai sejak awal**.

Pada kunjungan awal, dokter dapat menilai faktor risiko preeklamsia. WHO dan ACOG menyebut faktor risiko antara lain:

- **Pernah preeklamsia** di kehamilan sebelumnya
- **Hipertensi kronis**, **diabetes**, **penyakit ginjal**, atau **penyakit autoimun**
- **Hamil kembar**
- **Kehamilan pertama**, **riwayat preeklamsia dalam keluarga**, **usia ibu lebih tua** (ACOG: 35 tahun atau lebih; WHO: lebih dari 40 tahun), atau **obesitas**. Faktor-faktor ini dinilai bersama-sama.

Bagi ibu yang dinilai **berisiko sedang atau tinggi**, WHO dan ACOG merekomendasikan **aspirin dosis rendah** untuk menurunkan risiko preeklamsia. Aspirin ini **dimulai pada usia kehamilan tertentu sesuai keputusan dokter** (WHO: sebelum 20 minggu, idealnya sekitar 12 minggu; ACOG: 12–28 minggu, optimal sebelum 16 minggu). Bagi ibu yang tidak memiliki faktor risiko, ACOG menyatakan bukti saat ini tidak mendukung aspirin untuk mencegah keguguran atau masalah kehamilan lain.

> **Penting:** Aspirin hanya diminum **bila diresepkan dokter** setelah menilai risiko Ibu. **Jangan minum aspirin atau obat pengencer darah atas inisiatif sendiri.** Sampaikan ke dokter bila Ibu mengalami perdarahan atau nyeri perut selama mengonsumsinya.

Bagaimana risiko preeklamsia dinilai? Dokter menilai risiko dari **riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan Ibu**, termasuk faktor risiko di atas. **Bila tersedia**, dokter juga dapat memakai **kombinasi pengukuran tekanan darah, USG Doppler pembuluh darah rahim, dan pemeriksaan darah tertentu** untuk menilai risiko lebih rinci pada trimester pertama (FIGO 2019). Pemeriksaan tambahan ini tidak tersedia di semua tempat; penilaian faktor risiko tetap dilakukan untuk semua ibu hamil.

Skrining kesehatan jiwa

Buku KIA 2024 memasukkan **skrining kesehatan jiwa** dalam pemeriksaan kehamilan. Selama hamil, Ibu bisa merasa mudah sedih, mudah marah, cemas, stres, bahkan depresi. Kenali tandanya, misalnya **cemas dan khawatir berlebihan**, **gelisah, gemetar, sulit rileks**, **berdebar dan sesak**, **lelah berkepanjangan tetapi sulit tidur**, **mudah tersinggung**, dan **perubahan hubungan dengan suami**. Jika Ibu mengalaminya, **ceritakan saat periksa**. Ini bukan tanda Ibu lemah.

3.8 Imunisasi

- **Imunisasi tetanus (Td).** Status imunisasi tetanus Ibu akan **diskrining** pada pemeriksaan kehamilan dan imunisasi diberikan bila diperlukan (Buku KIA 2024, Permenkes 6/2024).
- **Influenza (vaksin inaktif).** Menurut **Rekomendasi Imunisasi Ibu Hamil POGI–HKFM 2026**, vaksin influenza diberikan **1 dosis** dan **aman di semua trimester**, termasuk trimester 1.
- **Tdap dan RSV** dijadwalkan **di trimester 3** (Tdap 27–36 minggu; RSV 32–36 minggu, minimal 14 hari sebelum perkiraan lahir).

Tanyakan kepada dokter vaksin mana yang sesuai untuk Ibu. POGI–HKFM menekankan bahwa keputusan tetap mempertimbangkan kondisi klinis dan riwayat medis masing-masing ibu.

Td atau Tdap? Tdap dianjurkan 1 kali di setiap kehamilan pada usia kehamilan 27–36 minggu (POGI–HKFM 2026). **Imunisasi Td program pemerintah tetap diberikan sesuai hasil skrining status imunisasi tetanus Ibu** (Buku KIA 2024). Dokter atau bidan akan menjelaskan jadwal yang sesuai untuk Ibu.

3.9 Aktivitas Fisik dan Olahraga

Jika kehamilan Ibu sehat dan dokter sudah mengizinkan, **aktivitas fisik itu baik**. Menurut ACOG, aktivitas fisik pada kehamilan normal **tidak meningkatkan risiko keguguran**, bayi berat lahir rendah, atau persalinan prematur. Manfaatnya antara lain mengurangi nyeri punggung, mengurangi sembelit, membantu kenaikan berat badan yang sehat, dan dapat menurunkan risiko diabetes kehamilan dan preeklamsia.

Di trimester 1, Buku KIA 2024 menganjurkan latihan seperti **pemanasan dan peregangan, senam panggul, serta pendinginan**. ACOG menyarankan target bertahap hingga sekitar **150 menit aktivitas intensitas sedang per minggu**, misalnya **jalan cepat** 30 menit selama 5 hari. Intensitas sedang berarti Ibu masih bisa bicara, tetapi tidak bisa bernyanyi. Jika sebelumnya jarang berolahraga, mulailah dari **5 menit sehari**, lalu tambah perlahan.

Hal yang perlu dihindari:

- Menurut Buku KIA: **aktivitas berat yang membuat Ibu kelelahan**, **melompat**, **mengejan**, **jongkok terlalu lama**, **membungkuk tanpa pegangan**, dan gerakan yang **berisiko mengganggu keseimbangan**.
- Menurut ACOG: **olahraga kontak atau berisiko benturan di perut** (misalnya sepak bola, basket, bela diri), **aktivitas berisiko jatuh** (misalnya berkuda, bersepeda di jalan tidak rata), **menyelam**, dan latihan di ruangan sangat panas. Hindari kepanasan, terutama di trimester 1, dan cukupi minum.

Berhenti dan hubungi dokter bila saat berolahraga muncul **perdarahan dari jalan lahir**, **pusing atau hampir pingsan**, **sesak sebelum mulai**

olahraga, **nyeri dada**, **sakit kepala**, **nyeri atau bengkak di betis**, **kontraksi teratur yang nyeri**, atau **keluar cairan dari jalan lahir** (ACOG).

Bekerja di kebun, di sawah, atau mengangkat beban

Banyak ibu tetap bekerja selama hamil, termasuk di kebun dan di sawah. Saran praktis saya:

- **Jangan memaksakan diri.** Kurangi pekerjaan berat yang membuat Ibu kelelahan. Hindari **jongkok terlalu lama** dan **membungkuk tanpa pegangan**, misalnya saat menanam atau memanen. Sering-seringlah berganti posisi, dan berdirilah pelan-pelan (Buku KIA 2024).
- **Minta bantuan untuk beban berat**, seperti karung, ember air, atau hasil panen. Pekerjaan berat termasuk hal yang tidak boleh dilakukan selama hamil (Buku KIA 2024).
- **Waspadai panas.** Minum air putih cukup sepanjang hari, kurangi kopi dan minuman manis, berteduh dan beristirahat secara berkala, dan hindari kerja berat di luar ruangan saat panas terik. Bila bisa, pilih jam yang lebih sejuk, pakai penutup kepala dan pakaian longgar (ACOG). Bila muncul pusing, lemas, atau rasa hendak pingsan, berhenti, berteduh, minum, dan segera periksa (ACOG).
- **Jauhi bahan kimia pertanian.** Sebisa mungkin jangan menyemprot atau mencampur pestisida dan pupuk kimia sendiri. Minta anggota keluarga lain mengerjakannya, dan jauhi area yang baru disemprot. ACOG menganjurkan ibu hamil mengurangi paparan bahan kimia berbahaya.
- **Hati-hati di jalan licin**, misalnya di pematang sawah atau jalan kebun setelah hujan. ACOG menyarankan ibu hamil menghindari aktivitas yang berisiko jatuh.
- **Berhenti bekerja dan periksa** bila muncul tanda di daftar di atas, misalnya perdarahan, nyeri perut, atau keluar cairan dari jalan lahir.

3.10 Hubungan Suami-Istri

Banyak pasangan ragu bertanya, padahal ini pertanyaan yang wajar. Buku KIA 2024 menyatakan **hubungan suami istri selama hamil boleh dilakukan selama kondisi kehamilan sehat**.

Beberapa hal yang perlu diketahui:

- Di awal kehamilan, gairah bisa menurun karena mual dan lelah, atau justru meningkat. Keduanya normal. Komunikasikan dengan pasangan.
- Leher rahim lebih banyak pembuluh darah saat hamil, sehingga **bercak darah ringan setelah berhubungan** kadang terjadi (ACOG). Namun **di trimester 1, setiap perdarahan tetap perlu segera diperiksa** (lihat 3.13), terutama bila disertai nyeri.
- **Tunda dulu** dan konsultasikan ke dokter bila ada **perdarahan**, **nyeri perut**, **keluar cairan dari jalan lahir**, atau bila dokter sudah menyarankan untuk menunda karena kondisi tertentu.

3.11 Obat, Jamu, dan Hal yang Sebaiknya Dihindari

Buku KIA 2024 dengan jelas menyebut beberapa **hal yang tidak boleh dilakukan** ibu selama kehamilan:

- **Minum obat tanpa resep dokter, termasuk jamu.**
- **Minum minuman beralkohol.**
- **Merokok atau terpapar asap rokok.** Minta anggota keluarga tidak merokok di dekat Ibu, juga di dalam rumah.
- **Stres berlebihan.**
- **Aktivitas berat** yang membuat Ibu kelelahan.
- Mulai **trimester 2 dan 3**: **tidur telentang lebih dari 10 menit**, untuk menghindari kekurangan oksigen pada bayi.

Tentang obat:

- Beri tahu dokter **semua obat rutin** yang Ibu minum, misalnya obat darah tinggi, obat kejang, obat tiroid, atau obat asma. **Jangan menghentikan obat rutin sendiri** saat tahu hamil. Sebagian obat justru penting dilanjutkan, sebagian lain perlu diganti dokter.
- Saat berobat ke dokter gigi, dokter umum, atau apotek, **selalu sampaikan bahwa Ibu sedang hamil**.
- **Jamu, ramuan, atau suplemen herbal** belum tentu aman untuk janin walaupun "alami". Tanyakan dulu.
- Hati-hati dengan **kosmetik yang mengandung zat berbahaya**. Lembar pemeriksaan dokter di Buku KIA juga menanyakan hal ini.

Bila Ibu sudah telanjur minum obat atau jamu

Banyak ibu sudah minum jamu, obat maag, atau obat pereda nyeri sebelum tahu dirinya hamil, atau karena disarankan keluarga dengan niat baik. Ibu tidak perlu merasa bersalah atau menyembunyikannya. Yang paling membantu adalah **bercerita apa adanya saat periksa**, supaya kita bisa mencari jalan yang aman bersama.

- **Jamu dan ramuan tradisional**, termasuk buatan sendiri atau pemberian keluarga: "alami" belum tentu aman untuk janin. Hentikan dulu, lalu tanyakan saat periksa (Buku KIA 2024).
- **Obat maag yang dibeli bebas**: tanyakan dulu ke dokter. Obat maag juga dapat menghambat penyerapan zat besi, jadi **jangan diminum bersamaan dengan TTD** (Buku KIA 2024). Bila perih ulu hati atau mual mengganggu, sampaikan ke dokter.
- **Obat pereda nyeri atau obat flu yang dibeli bebas**: tanyakan dulu ke dokter atau apoteker, dan selalu sampaikan bahwa Ibu sedang hamil. Sakit kepala berat, demam tinggi, atau nyeri perut hebat jangan diredam sendiri dengan obat; segera periksa (lihat 3.12).

- **Suplemen, herbal, atau "penguat kandungan" yang dijual online**: jangan membeli berdasarkan iklan atau testimoni. Tanyakan dulu ke dokter atau bidan.

Bawalah **kemasan atau foto kemasan** semua obat, jamu, dan suplemen yang pernah Ibu minum saat periksa (lihat 3.4).

3.12 Tanda Bahaya Trimester 1

> **Jika mengalami salah satu tanda di bawah ini, jangan menunggu jadwal kontrol. Segera ke Puskesmas, rumah sakit, atau IGD terdekat.** (Buku KIA 2024)

Tanda bahaya trimester 1 (Buku KIA 2024):

- **Perdarahan** dari jalan lahir
- **Nyeri perut hebat**
- **Mual dan muntah hebat** (tidak bisa makan dan minum, lemas, kencing sedikit)
- **Demam tinggi**
- **Sakit saat kencing**, atau **keputihan atau gatal di daerah kemaluan**
- **Diare berulang**

Masalah lain yang juga perlu segera diperiksakan (Buku KIA 2024):

- **Demam, menggigil, dan berkeringat.** Di daerah endemis malaria, ini bisa menjadi gejala malaria.
- **Batuk lama**, lebih dari 2 minggu
- **Jantung berdebar-debar** atau **nyeri di dada**
- **Sulit tidur dan cemas berlebihan**

Penjelasan tambahan tentang perdarahan dan nyeri (ACOG):

- Perdarahan di trimester pertama cukup sering, terjadi pada sekitar **15–25 dari 100 kehamilan**, dan **banyak yang tidak berbahaya**. Namun perdarahan juga bisa menjadi tanda **keguguran** atau **hamil di luar kandungan (kehamilan ektopik)**. Karena itu, **setiap perdarahan di trimester 1, sekecil apa pun, perlu segera diperiksa di IGD atau fasilitas kesehatan hari itu juga** (lihat 3.13).
- **Kehamilan ektopik dapat mengancam nyawa.** Waspadai **perdarahan disertai nyeri perut atau panggul, nyeri di bahu, lemas, atau pingsan**. Ini kondisi **gawat darurat. Segera ke IGD.**

Bila Ibu tinggal di daerah endemis malaria, atau baru bepergian ke sana. Malaria pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, kelahiran sebelum waktunya, kurang darah, dan bayi berat lahir rendah. Karena itu, di daerah endemis tinggi, ibu hamil diskrining malaria saat kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama dan diberi kelambu (Permenkes 22/2022). Tidurlah di dalam kelambu. Bila Ibu **demam, menggigil, dan berkeringat**, segera periksa dan ceritakan tempat tinggal serta riwayat perjalanan Ibu.

Jangan menunda ke IGD. Banyak ibu ragu ke IGD karena takut merepotkan, menunggu suami pulang, menunggu pagi, atau berharap keluhan hilang sendiri. Pada tanda bahaya, menunggu justru bisa berbahaya. Siapkan dari sekarang siapa yang akan mengantar, kendaraan yang dipakai, dan nomor **119**. Bila ragu apakah keluhan Ibu termasuk gawat, lebih baik diperiksa.

3.13 Kapan ke Dokter, Kapan ke IGD

Situasi	Yang dilakukan
Baru tahu hamil / terlambat haid	**Jadwalkan periksa** ke dokter/bidan secepatnya (Buku KIA: bila terlambat 1 minggu)
Mual-muntah, tetapi masih bisa makan dan minum	Coba langkah di 3.3; sampaikan saat kontrol
Mual-muntah mengganggu aktivitas, berat badan turun	**Periksa ke dokter dalam waktu dekat**
Sejak pagi tidak ada minuman yang bisa masuk, kencing sangat sedikit/gelap, pusing saat berdiri	**Segera ke IGD**
Perdarahan apa pun, termasuk bercak/flek sedikit tanpa nyeri	**Segera ke IGD/fasilitas kesehatan hari itu juga**; jangan menunggu jadwal kontrol
Perdarahan banyak, nyeri perut hebat, nyeri bahu, lemas/pingsan	**Segera ke IGD / hubungi 119**
Demam tinggi, menggigil	**Segera periksa**
Sakit saat kencing, keputihan berbau/gatal	**Periksa ke dokter/bidan**
Sedih/cemas terus-menerus, sulit tidur	**Ceritakan ke dokter/bidan**; minta skrining kesehatan jiwa

Nomor darurat: 119 (layanan gawat darurat medis/ambulans Kemenkes, bebas biaya), atau **IGD terdekat**. Bila Ibu berada di area Lampung Tengah: RS Harapan Bunda, 0800 1503363. Simpan juga nomor fasilitas kesehatan terdekat dan nomor keluarga yang bisa mengantar.

3.14 Pertanyaan yang Sering Diajukan di Ruang Praktik

Berikut pertanyaan yang sering diajukan ibu hamil, beserta jawaban singkat berdasarkan pedoman.

1. "Dok, saya sudah minum kopi sebelum tahu hamil. Bahaya, tidak?" Tidak perlu panik. Menurut ACOG, konsumsi kafein sedang, yaitu **kurang dari 200 mg per hari**, tidak tampak sebagai faktor utama penyebab keguguran atau kelahiran prematur. Batas ini kira-kira setara dengan **1 cangkir kopi ukuran 12 ons (sekitar 350 ml)**. Mulai sekarang, batasi kopi, teh, dan minuman bersoda (Buku KIA 2024), dan jangan meminumnya bersamaan dengan TTD.

2. "Boleh naik motor saat hamil muda?" ACOG menyarankan ibu hamil menghindari aktivitas yang berisiko jatuh. Saran saya: bila memungkinkan, kurangi naik motor, terutama untuk perjalanan jauh dan di jalan rusak. Bila harus, berkendaralah pelan, pakai helm, dan hindari jalan berlubang. Bila Ibu jatuh atau perut terbentur, segera periksa, terutama bila muncul perdarahan, nyeri perut, atau keluar cairan dari jalan lahir.

3. "Kok di USG janinnya belum kelihatan?" Pada kehamilan yang masih sangat awal, kantong kehamilan, janin, atau denyut jantungnya memang bisa belum terlihat. Ini belum tentu berarti ada masalah. Dokter akan menentukan kapan USG perlu diulang. Namun bila ada perdarahan, nyeri perut, nyeri bahu, lemas, atau pingsan, jangan menunggu jadwal USG: **segera ke IGD** (lihat 3.6).

4. "Mual saya tiba-tiba hilang. Apakah itu tanda bahaya?" Mual memang naik-turun, dan pada sebagian besar ibu mereda sekitar usia kehamilan **14 minggu** (ACOG). Berkurangnya mual saja tidak bisa dipakai untuk menilai kondisi janin, baik atau buruk. Yang perlu diwaspadai adalah tanda bahaya, seperti perdarahan atau nyeri perut (lihat 3.12). Bila Ibu cemas, sampaikan saat kontrol.

5. "Boleh makan nanas atau durian?" Pedoman yang dipakai buku ini (Buku KIA, WHO, ACOG) tidak memuat larangan khusus untuk nanas atau durian. Buah tetap bagian dari **4 porsi buah sehari** (Buku KIA 2024). Makanlah dalam porsi wajar dan bervariasi. Bila Ibu memiliki diabetes atau gula darah tinggi, tanyakan porsi buah yang sesuai kepada dokter atau ahli gizi.

6. "Boleh minum tablet tambah darah dengan teh manis?" Sebaiknya tidak. Teh, kopi, susu, dan obat maag dapat menghambat penyerapan zat besi. Minumlah TTD dengan air putih atau bersama buah sumber vitamin C, sebaiknya malam hari sebelum tidur (Buku KIA 2024).

3.15 Ringkasan Trimester 1

- ☐ Periksa kehamilan **segera setelah terlambat haid** (Buku KIA: bila terlambat 1 minggu)
- ☐ Minimal 1 kali periksa ke **dokter** di trimester 1, termasuk **USG dan laboratorium**
- ☐ Bawa **Buku KIA** setiap kali periksa
- ☐ Minum **TTD/MMS setiap hari**, malam sebelum tidur, tidak bersama teh/kopi/susu
- ☐ Pastikan asupan **asam folat** (biasanya sudah ada dalam TTD/MMS)
- ☐ Makan **sedikit tapi sering**, minum 8–12 gelas air, gunakan **garam beryodium** secukupnya
- ☐ Tes **Hb, golongan darah, gula darah, protein urin, HIV, sifilis, hepatitis B**
- ☐ Diskusikan **risiko preeklamsia** dengan dokter
- ☐ Tanyakan status **imunisasi** (Td, influenza)
- ☐ Hindari **rokok/asap rokok, alkohol, obat dan jamu tanpa resep**
- ☐ Bergerak aktif secara ringan bila dokter mengizinkan
- ☐ Kenali **tanda bahaya**, simpan nomor **119** dan nomor **IGD/fasilitas kesehatan terdekat** (lihat 3.13)

Sumber (Bab 3)

Semua sumber di bawah dibuka dan dibaca saat penyusunan (19–29 Oktober 2026). Tanggal dalam kurung menunjukkan kapan sumber dibuka atau dibuka ulang.

Indonesia

1. Kementerian Kesehatan RI. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) 2024.* Halaman Kehamilan, Trimester 1 (porsi makan, TTD/MMS, tanda bahaya, perawatan sehari-hari, kesehatan jiwa) dan lembar pencatatan tenaga kesehatan (10 T, USG trimester 1, laboratorium). Untuk kejang dan bengkak wajah/tangan (21 Okt 2026): hlm. 23 "Tanda Bahaya Pada Proses Melahirkan" (ibu mengalami kejang) dan hlm. 27 "Tanda Bahaya Pada Ibu Setelah Melahirkan (Nifas)" (nyeri ulu hati, mual muntah, sakit kepala, pandangan kabur, kejang dengan atau tanpa bengkak pada kaki, tangan, dan wajah). https://kesprimkom.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/Buku_KIA_2024.pdf

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Bagian pelayanan kesehatan ibu hamil: K6, minimal 2 kali oleh dokter/SpOG di trimester 1 dan 3 termasuk USG, 10 T. https://p2.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Permenkes-Nomor-6-Tahun-2024.pdf

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/75/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Ultrasonografi untuk Antenatal Care bagi Dokter Umum di Layanan Primer. USG pada K1 (trimester 1) dan K5 (trimester 3). https://kesprimkom.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/Kepmenkes_nomor_HK.01.07_MENKES_75_2023_Juknis_penggunaan_USG.pdf

4. Kementerian Kesehatan RI. *Petunjuk Teknis Gerakan #BumilSehat.* https://kesprimkom.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/Juknis_Gerakan_Bumil_Sehat.pdf

5. POGI dan HKFM. *Peluncuran Rekomendasi Imunisasi Ibu Hamil POGI-HKFM 2026* (diumumkan pada PIT POGI XXVIII, 22 Juli 2026). https://pogi.or.id/r/180/Peluncuran%20Rekomendasi%20Imunisasi%20Ibu%20Hamil%20POGI-HKFM%202026 (artikel peluncuran di situs POGI, dibuka ulang 21 Oktober 2026; dokumen rekomendasi lengkap belum dibuka)

6. Kementerian Kesehatan RI. *Kejadian Gawat Darurat Medik, Laporkan ke 119.* https://kemkes.go.id/id/kejadian-gawat-darurat-medik-laporkan-ke-119

WHO

7. World Health Organization. *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience* (2016), beserta daftar pembaruan (2020–2022). https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912

8. WHO. *2016 WHO Recommendations: Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience* (ringkasan rekomendasi: zat besi-asam folat, kalsium, USG sebelum 24 minggu, mual: jahe/chamomile/vitamin B6/akupunktur, model minimal 8 kontak). https://www.who.int/docs/default-source/reproductive-health/maternal-health/anc.pdf

9. WHO. *Maternal and fetal assessment update: imaging ultrasound before 24 weeks of pregnancy* (2022). https://www.who.int/publications/i/item/9789240046009

10. WHO. *WHO recommendations on antiplatelet agents for the prevention of pre-eclampsia* (2021). Faktor risiko tinggi termasuk usia lebih dari 40 tahun (dibuka ulang 21 Okt 2026). https://www.who.int/publications/i/item/9789240037540

11. WHO. *WHO recommendation: Calcium supplementation during pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications* (2018). Keterangan rekomendasi: waktu mulai belum jelas dari bukti; suplementasi dapat dimulai sejak kontak ANC pertama (dibuka ulang 21 Okt 2026). https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a3277bb9-06a8-44eb-bd5a-2680c07649fc/content

12. WHO e-Library of Evidence for Nutrition Actions (eLENA). *Daily iron and folic acid supplementation during pregnancy.* https://www.who.int/tools/elena/interventions/daily-iron-pregnancy

ACOG

13. ACOG. *Morning Sickness: Nausea and Vomiting of Pregnancy* (FAQ126). https://www.acog.org/womens-health/faqs/morning-sickness-nausea-and-vomiting-of-pregnancy

14. ACOG. *Healthy Eating During Pregnancy* (FAQ001). https://www.acog.org/womens-health/faqs/healthy-eating-during-pregnancy

15. ACOG. *Exercise During Pregnancy* (FAQ119). https://www.acog.org/womens-health/faqs/exercise-during-pregnancy

16. ACOG. *Bleeding During Pregnancy* (FAQ038). https://www.acog.org/womens-health/faqs/bleeding-during-pregnancy

17. ACOG. *Prenatal Genetic Screening Tests* (FAQ165). https://www.acog.org/womens-health/faqs/prenatal-genetic-screening-tests

18. ACOG & SMFM. *Low-Dose Aspirin Use During Pregnancy* (Committee Opinion No. 743, 2018; disertai Practice Advisory Desember 2021). https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2018/07/low-dose-aspirin-use-during-pregnancy (dibuka ulang 21 Okt 2026: faktor risiko sedang termasuk usia ibu 35 tahun atau lebih)

19. ACOG. *Preeclampsia and High Blood Pressure During Pregnancy* (FAQ034; terakhir ditinjau April 2025). Gejala: bengkak di wajah atau tangan, sakit kepala yang tidak hilang, gangguan penglihatan; preeklamsia dapat menyebabkan kejang. (21 Okt

2026) https://www.acog.org/womens-health/faqs/preeclampsia-and-high-blood-pressure-during-pregnancy

20. ACOG. *Ectopic Pregnancy* (FAQ155; terakhir ditinjau April 2026). Nyeri mendadak hebat, nyeri bahu, atau lemas: segera ke IGD. (21 Okt 2026) https://www.acog.org/womens-health/faqs/ectopic-pregnancy

Sumber tambahan

21. WHO e-Library of Evidence for Nutrition Actions (eLENA). *Calcium supplementation during pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications.* "In populations with low dietary calcium intake, daily calcium supplementation … is recommended for pregnant women to reduce the risk of pre-eclampsia" (dibuka 26 Okt 2026). https://www.who.int/tools/elena/interventions/calcium-pregnancy

22. Poon LC, Shennan A, Hyett JA, dkk. *The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) initiative on pre-eclampsia: A pragmatic guide for first-trimester screening and prevention.* Int J Gynaecol Obstet. 2019;145 Suppl 1:1–33. doi:10.1002/ijgo.12802. PMID 31111484. Skrining kombinasi trimester 1 (faktor risiko ibu, tekanan arteri rerata, Doppler arteri uterina, PlGF); bila sumber daya terbatas, minimal faktor risiko ibu + tekanan darah (dicek via Crossref & PubMed 26 Okt 2026). https://doi.org/10.1002/ijgo.12802

23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak. Lampiran: penelusuran, tes, dan konseling pasangan seksual ibu hamil dengan HIV, sifilis, atau hepatitis B; pelibatan pasangan dan keluarga. Sebagian pasal dicabut oleh Permenkes 3/2026; Pasal 6, 13, 19, 21, 23 dan Lampiran dinyatakan masih berlaku (dibuka 27 Okt 2026). https://jdih.kemkes.go.id/storage/documents/pdfs/2017permenkes052.pdf

24. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) dan (4): pelayanan berjenjang dimulai dari FKTP tempat peserta terdaftar, kecuali keadaan kegawatdaruratan medis; FKTP wajib merujuk ke FKRTL. Pasal 63 ayat (1): peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan, baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (dibuka ulang 29 Okt 2026). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/2018/82TAHUN2018PERPRES.pdf

25. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria. Dampak malaria pada ibu hamil (keguguran, lahir sebelum waktunya, kurang darah, berat lahir rendah); skrining malaria ibu hamil terintegrasi kunjungan pertama di daerah endemis tinggi; pemberian kelambu (dibuka 27 Okt 2026). https://jdih.kemkes.go.id/storage/documents/pdfs/2022permenkes022.pdf

26. Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. *Garam Beryodium Bukan Sekedar Garam Biasa.* Label "Garam Beryodium"; SNI 30–80 ppm (dibuka 27 Okt 2026). https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/1659/garam-beryodium-bukan-sekedar-garam-biasa

27. Kementerian Kesehatan RI, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. *Buku Surveilans untuk Mengatasi Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium.* Uji cepat garam: 2–3 tetes cairan uji, biru keunguan berarti beryodium; uji kualitatif (dibuka 27 Okt 2026). https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4298/1/Buku%20Surveilans%20untuk%20Mengatasi%20Masalah%20Gangguan%20Akibat%20Kekurangan%20Iodium.pdf

28. ACOG. *Ask ACOG: How much coffee can I drink while I'm pregnant?* Kurang dari 200 mg kafein per hari, kira-kira 1 cangkir 12 ons (dibuka 27 Okt 2026). https://www.acog.org/womens-health/experts-and-stories/ask-acog/how-much-coffee-can-i-drink-while-pregnant

29. ACOG. *Moderate Caffeine Consumption During Pregnancy* (Committee Opinion No. 462, 2010). Konsumsi kafein sedang (<200 mg/hari) tidak tampak sebagai faktor utama keguguran atau kelahiran prematur (dibuka 27 Okt 2026). https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2010/08/moderate-caffeine-consumption-during-pregnancy

30. ACOG. *Ask ACOG: What should I know about extreme heat and pregnancy?* (Agustus 2026). Cukupi cairan, kurangi kafein dan minuman manis, batasi paparan matahari, hindari aktivitas luar ruang berintensitas tinggi (dibuka 27 Okt 2026). https://www.acog.org/womens-health/experts-and-stories/ask-acog/what-should-i-know-about-extreme-heat-and-pregnancy

31. ACOG. *Reducing Prenatal Exposure to Toxic Environmental Agents* (Committee Opinion No. 832, 2021). Mengurangi paparan bahan kimia beracun pada masa prakehamilan dan kehamilan (dibuka 27 Okt 2026). https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2021/07/reducing-prenatal-exposure-to-toxic-environmental-agents

32. Health Service Executive (HSE, Irlandia). *Dizziness and fainting in pregnancy* (ditinjau 9 Maret 2026). Pencegahan, apa yang dilakukan saat hendak pingsan, dan kapan harus segera periksa (dibuka 27 Okt 2026). https://www2.hse.ie/conditions/dizziness-and-fainting-pregnancy/

33. NHS (Inggris). *Stomach pain in pregnancy.* Nyeri ringan yang membaik dengan istirahat atau berganti posisi; segera periksa bila disertai perdarahan, nyeri hebat, atau tidak hilang setelah istirahat 30–60 menit (dibuka 27 Okt 2026). https://www.nhs.uk/pregnancy/related-conditions/common-symptoms/stomach-pain/

34. NHS (Inggris). *Leg cramps* (ditinjau 1 Desember 2023). Peregangan dan pijat betis; periksa bila lebih dari 10 menit, mengganggu tidur, atau disertai kebas atau bengkak (dibuka 27 Okt 2026). https://www.nhs.uk/conditions/leg-cramps/

35. Kementerian Kesehatan RI. *Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN.* Pasal 2: fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama (dibuka 29 Okt 2026). https://www.kemkes.go.id/id/permenkes-nomor-71-tahun-2013-tentang-pelayanan-kesehatan-pada-jkn

E-book ini adalah materi edukasi dan bukan pengganti pemeriksaan, diagnosis, atau pengobatan oleh tenaga kesehatan. Dalam keadaan darurat, hubungi 119 atau segera ke IGD terdekat. Bila Ibu berada di area Lampung Tengah: RS Harapan Bunda, 0800 1503363.